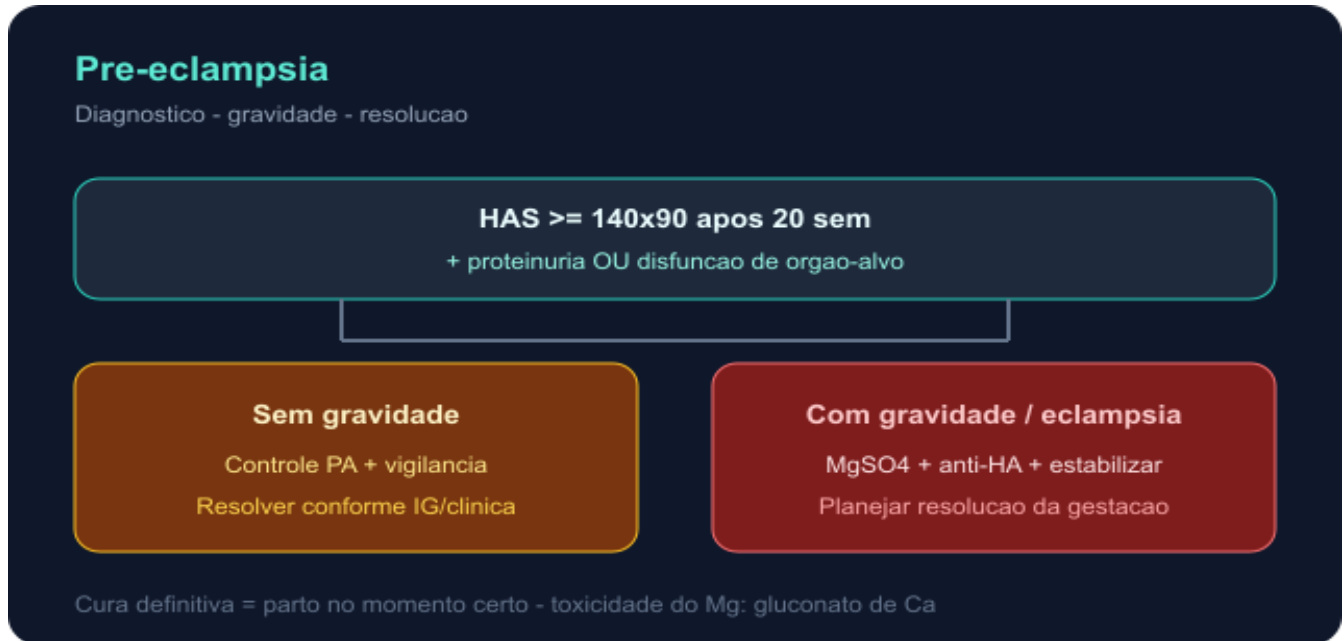


Pré-eclâmpsia · critérios e conduta

HAS gestacional + proteinúria ou disfunção de órgão-alvo após 20 semanas. Gravidade e idade gestacional guiam a resolução.

Mapa mental: diagnóstico !' gravidade !' conduta.



Diagnóstico (ideia central)

- PA $\geq$ 140x90 mmHg após 20 semanas em gestante previamente normotensa
- Associada a proteinúria (ex.: $\geq$ 300 mg/24 h ou relação proteína/creatinina $\geq$ 0,3) OU
- Sinais de disfunção de órgão-alvo mesmo sem proteinúria (PE com critérios de gravidade)

Critérios de gravidade (alto rendimento)

- PA $\geq$ 160x110 mmHg
- Plaquetopenia, elevação de enzimas hepáticas, creatinina elevada
- Edema pulmonar, cefaleia intensa / escotomas / epigastralgia
- Restrição de crescimento fetal / alterações de bem-estar fetal

Conduta em uma frase

Situação | Foco

PE sem gravidade, IG prematura | Controle pressórico + vigilância materna/fetal

PE com gravidade | Estabilizar, MgSO₄, anti-hipertensivo, planejar resolução

Eclâmpsia | ABC, MgSO₄, estabilizar e resolver a gestação

Cura definitiva | Resolução da gestação (parto) no momento adequado

MgSO₄

Dica - MgSO₄

Indicação clássica: prevenção/tratamento de convulsão na PE grave/eclâmpsia. Monitore reflexos, diurese e FR — toxicidade !' suspender e gluconato de cálcio.

Armadilha

Atenção - Armadilha

HAS crônica " PE. Em hipertensa crônica, suspeite de PE sobreposta se houver piora pressórica + proteinúria nova ou disfunção de órgão após 20 semanas.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Pré-eclâmpsia fecha com critérios diagnósticos, marcadores de gravidade, sinais de iminência de eclâmpsia e toxicidade do MgSO₄.

Checklist clássico de PE com critérios de gravidade (prova).

PE - criterios de gravidade

PA alta + disfuncao de orgao-alvo

- 1 PA $\geq$ 160 x 110 mmHg
- 2 Plaquetas < 100.000
- 3 TGO/TGP elevadas (2x)
- 4 Creatinina elevada / oliguria
- 5 Edema pulmonar
- 6 Cefaleia / escotomas / epigastralgia
- 7 Restricao / sofrimento fetal

Qualquer 1 criterio = PE com gravidade

Sinais de toxicidade do sulfato de magnésio e antídoto.

MgSO₄ - toxicidade

Monitorar e reverter

Perda de reflexo patelar	alerta
FR < 12 / depressao respiratoria	grave
Oliguria (acumulo)	risco
Sonolencia / confusao	alerta
Parada cardiorrespiratoria	emerg

Antidoto: gluconato de calcio EV

Diagnóstico de PE (ideia de prova)

Item | Critério clássico

Momento | Após 20 semanas (prévia normotensa)

PA | "e 140 x 90 mmHg (2 medidas)

Proteinúria | "e 300 mg/24 h ou P/C "e 0,3 ou fita "e 1+

Sem proteinúria | PE se houver disfunção de órgão-alvo

Iminência de eclâmpsia (tríade clássica +)

- Cefaleia intensa e persistente
- Distúrbios visuais (escotomas, visão turva, fotopsia)
- Dor epigástrica / hipocôndrio direito
- Hiperreflexia, agitação — pensar MgSO₄ e resolução

Conduta-chave

Atenção - Conduta-chave

PE com gravidade ou eclâmpsia: estabilizar + MgSO₄ + anti-hipertensivo + planejar resolução. Cura definitiva = parto no momento certo.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1